Agadez, région d'Agadez

L'hiver paraît calme dans le tracker de la chaleur, mais il ne l'est pas : ici, on meurt de la méningite dès janvier, d'une année pastorale ratée et sur les routes du désert. Les antibiotiques doivent donc être dans chaque formation sanitaire avant le 15 décembre.

RÉGION	DÉCÈS SUPPLÉMENTAIRES DUS À LA CHALEUR	PÉRIODE	ALÉA PRINCIPAL
Région d'Agadez (GADM NER.1_1), échelle régionale	93 prévus d'oct. 2026 à mars 2027, dont 43 en mars ; 310 déjà survenus (juin–sept.)	Prévision sur 6 mois, octobre 2026 – mars 2027	Méningite (janv.–mai) ; chaleur dès mars ; sécheresse pastorale ; routes du désert ; soudure 2027

24 recommandations vérifiées sur 24. 3 confirmées, 17 corrigées, 3 non vérifiées, 1 contre-indiquée, soit les 8 actions classées (toutes corrigées), les 7 fiches « À ne pas faire » (3 confirmées, 2 corrigées, 1 non vérifiée, 1 contre-indiquée : une étape en projet qui promettait aux éleveurs une aide sécheresse) et les 9 étapes « Pour vous » (7 corrigées, 2 gardées comme conseils généraux de sécurité). Donnée d'exposition : El Niño Heat Mortality Tracker du Climate Impact Lab, version du 26 octobre 2026, avant évaluation par les pairs, publiée pour la région d'Agadez et non pour la ville, chaleur seule. Aucune part de la ville n'est calculée, sa population étant contestée. Après vérification, l'objectif de financement passe de 45 503 350 FCFA (77 500 USD), chiffre du panel, à 51 374 750

SYNTHÈSE — EN UN COUP D'ŒIL



16,97° N 7,99° E, Niger · Natural Earth

- **Le risque.** Un déficit fourrager « très marqué », la méningite dès janvier et 43 décès dus à la chaleur prévus en mars ; ici, le pire vient pendant la soudure de l'année suivante.
- **Pour vous.** D'ici le 31 décembre, vérifiez que chaque personne de 1 à 19 ans a reçu le vaccin gratuit contre la méningite de 2025 ; sinon, renseignez-vous au CSI.
- **L'argent.** 22,0 à 168,8 millions de FCFA (37 500 à 287 500 USD) ; c'est le stock de traitement de la méningite dans les CSI qui sauve le plus de vies.
- **À ne pas faire.** Ne dites pas aux éleveurs que l'argent du protocole sécheresse arrive : il ne couvre que 500 ménages dans tout le Niger.

Pour vous, habitants	9 étapes	p. 2
Que faire	**8** actions	p. 6
Qui fait quoi	matrice RACI	p. 15
Où l'argent est le plus utile	financement	p. 15
À ne pas faire	**7** points	p. 18
Ce qui s'est passé ici	l'historique	p. 21
Comment cette note a été produite	méthodologie	p. 23
Références	sources	p. 26

* Formulation suggérée : à vérifier auprès d'un agent de santé avant diffusion

FCFA (87 500 USD) (+13 %). L'Adaptation Inventory du Climate Impact Lab, chargé dans le navigateur, n'a renvoyé aucune entrée aux agents ; aucun précédent n'a pu y être confirmé.

POUR VOUS, HABITANTS

9 ÉTAPES

Pour une famille d'Agadez, cet El Niño arrive par étapes : la méningite de janvier à mai, des nuits froides de décembre à février, la chaleur à partir de mars, puis une soudure 2027 difficile après une très mauvaise année pastorale. L'événement le plus meurtrier de 2026 s'est produit sur la route du désert. Les actions classées plus bas s'adressent à la région et à ses partenaires. Voici celles que vous pouvez mener vous-même.

De janvier à mai, emmenez le jour même au CSI toute personne qui a de la fièvre et la nuque raide, ainsi que tout nourrisson mou ou dont la fontanelle est bombée *

PARTIELLEMENT CONFIRMÉ · ISSU DE L'ACTION 1

ÉCHÉANCE	COÛT POUR VOUS	PROTÈGE
janvier–mai 2027	gratuit pour les moins de cinq ans ; pour les autres, les médicaments sont généralement offerts en période d'épidémie : renseignez-vous, sans attendre	les enfants et les jeunes adultes

En 2024, Agadez avait le deuxième taux d'attaque de méningite le plus élevé du Niger, 11,5 cas pour 100 000 habitants, et 6,1 % des cas sont décédés à l'échelle nationale. Ce sont les antibiotiques donnés tôt qui maintiennent ce chiffre bas. La politique de gratuité des soins du Niger couvre l'ensemble des soins des enfants de moins de cinq ans. Elle ne garantit pas la gratuité du traitement de la méningite pour les personnes plus âgées, et les formations sanitaires attendent plus de 50 milliards de FCFA (85 millions USD) d'arriérés au titre de la gratuité des soins ; un CSI peut donc faire payer. *

Vérifiez que chaque membre du ménage âgé de 1 à 19 ans a reçu le vaccin contre la méningite en novembre–décembre 2025 ; si quelqu'un l'a manqué, ou si un enfant a eu 1 an depuis, renseignez-vous au CSI

PARTIELLEMENT CONFIRMÉ · ISSU DE L'ACTION 1

* Formulation suggérée : à vérifier auprès d'un agent de santé avant diffusion

ÉCHÉANCE
31 décembre 2026

COÛT POUR VOUS
aucun ; le vaccin était gratuit

PROTÈGE
toutes les personnes de 1 à 19 ans

Le Niger a mené en novembre–décembre 2025 sa première campagne préventive avec le nouveau vaccin pentavalent (Men5CV), pour les 1–19 ans, sur l'ensemble du territoire, et a atteint 12,3 millions de personnes (OMS, septembre 2026). Aucune source ne cite Agadez, mais le gouvernement l'a présentée comme nationale. Les enfants nés depuis ne sont pas couverts tant que la vaccination de routine à 16 mois n'a pas commencé, et ce démarrage n'a pas pu être confirmé.

Par les nuits froides, ne laissez jamais un réchaud à charbon de bois (kanoun) allumé dans une pièce fermée ; laissez une fenêtre ou une porte ouverte, ou éteignez-le avant de dormir *

NON VÉRIFIÉ POUR LE NIGER · SELON LE RÔLE

ÉCHÉANCE
décembre 2026 – février 2027

COÛT POUR VOUS
aucun

PROTÈGE
toutes les personnes qui dorment dans la pièce

Conseil général de sécurité, et non constat propre à Agadez. Les nuits de janvier à Agadez sont en moyenne d'environ 13,5 °C, avec de rares minimales proches de 2 °C. Un réchaud dans une pièce fermée dégage du monoxyde de carbone, qui tue sans prévenir : deux personnes sont mortes ainsi à Buea, au Cameroun, en août 2026, et la France enregistre de tels décès chaque année. Aucune série de cas n'a été trouvée pour le Niger.*

Avant le 1er mars, gardez deux bidons de 20 litres d'eau de boisson, propres et couverts, et renouvelez l'eau chaque semaine

NON VÉRIFIÉ · SELON LE RÔLE

ÉCHÉANCE
1er mars 2027

COÛT POUR VOUS
environ 3 000 à 5 000 FCFA (5 à 9 USD) pour deux bidons, estimation sans source

PROTÈGE
l'eau de boisson pendant les semaines les plus chaudes

Une précaution de bon sens, sans base de preuves. En avril et en mai, Agadez atteint environ 40 à 43 °C, et la région a connu 48 °C en avril 2024. Une réserve d'eau évite que quiconque en manque lors d'une coupure d'approvisionnement ou pendant les jours les plus chauds. Aucun prix de marché publié n'a été trouvé pour les bidons.

* Formulation suggérée : à vérifier auprès d'un agent de santé avant diffusion

Quand la chaleur revient en mars : buvez, mouillez votre peau et vos vêtements, restez à l'ombre et reposez-vous à la mi-journée ; ne comptez pas sur un ventilateur pour une personne âgée, et passez voir les voisins âgés qui vivent seuls *

PARTIELLEMENT CONFIRMÉ | ISSU DE L'ACTION 3

ÉCHÉANCE	COÛT POUR VOUS	PROTÈGE
mars–mai 2027	aucun	les personnes âgées, les personnes souffrant d'hypertension et les jeunes enfants

Sur les 93 décès dus à la chaleur prévus dans la région d'octobre à mars, 43 surviennent en mars, et avril et mai sont encore plus chauds. Par la chaleur très sèche d'Agadez, un ventilateur qui souffle sur une peau sèche peut réchauffer le corps : une revue de 2024 déconseille les ventilateurs au-dessus de 35 °C pour les plus de 65 ans, et les modélisations situent le seuil à 37–38 °C pour les personnes âgées. Une peau mouillée rafraîchit ; l'air en mouvement sur une peau sèche, non. Les personnes âgées qui vivent seules dans les maisons en banco de la vieille ville sont celles que personne ne voit. *

Procurez-vous des sachets de sels de réhydratation orale (SRO) au CSI ; à défaut, mélangez 6 cuillères à café rases de sucre et ½ cuillère à café rase de sel dans 1 litre d'eau propre, et jetez le mélange au bout de 24 heures *

PARTIELLEMENT CONFIRMÉ | ISSU DE L'ACTION 3

ÉCHÉANCE	COÛT POUR VOUS	PROTÈGE
avant le 1er mars 2027	bien moins de 100 FCFA (0,17 USD) par litre pour la préparation maison, estimation	un enfant qui a la diarrhée ; toute personne déshydratée par la chaleur

C'est la recette maison citée par l'OMS lorsque les sachets ne sont pas disponibles. Une ancienne recette (8 cuillères de sucre et 1 de sel) circule encore. Trop de sel est le principal danger ; c'est pourquoi les sachets passent en premier. *

Achetez vos céréales dès maintenant et jusqu'en décembre, par lots de 25 kg si vous ne pouvez pas acheter un sac entier, et vérifiez le poids

PARTIELLEMENT CONFIRMÉ | ISSU DE L'ACTION 6

ÉCHÉANCE	COÛT POUR VOUS	PROTÈGE

* Formulation suggérée : à vérifier auprès d'un agent de santé avant diffusion

novembre–décembre 2026	moins de 29 500 FCFA (50 USD) pour 100 kg de mil au prix de soudure de juin, 295 FCFA/kg ; à ce prix, 25 kg coûtent environ 7 400 FCFA (12,60 USD)	l'alimentation pendant la soudure 2027

En juin 2026, le Système d'information sur les marchés agricoles (SIMA) relevait le mil à 295 FCFA/kg dans la commune d'Agadez, au-dessus de la moyenne nationale de 271. Les prix devraient être plus bas après la récolte, mais aucun chiffre actuel pour Agadez n'a été trouvé. Les prix de soudure augmentent à partir de mai, jusqu'à 25 % pour le mil. L'Institut national de la statistique signale que les sacs pèsent souvent moins que le poids annoncé. Un sac entier représente plusieurs semaines de revenu ; mieux vaut donc acheter 25 kg à la fois que s'endetter.

Si vous avez des animaux : vendez les plus faibles entre novembre et janvier, et demandez à la Croix-Rouge nigérienne à Agadez et à votre chef de quartier ou de village si une liste de bénéficiaires est en préparation après les résultats fourragers de novembre ; ne comptez pas sur cet argent

PARTIELLEMENT CONFIRMÉ · ISSU DE L'ACTION 4

ÉCHÉANCE	COÛT POUR VOUS	PROTÈGE
novembre 2026 – janvier 2027	aucun ; vendre tôt rapporte davantage	la valeur du troupeau et l'alimentation du ménage

Le service pastoral régional (CILSS/AGRHYMET) qualifie le déficit fourrager 2026 d'Agadez de « très marqué ». En 2010, les éleveurs qui ont attendu ont vendu sur un marché en baisse pendant que le prix des céréales montait. En juin 2026, une chèvre permettait encore d'acheter environ une unité de mil (termes de l'échange de 0,99). Si une liste est établie, veillez à ce que les ménages d'éleveurs vulnérables, en particulier ceux dirigés par des femmes, y figurent.

Avant tout voyage dans le désert à partir de mars, emportez au moins 10 litres d'eau par personne et par jour prévu, plus deux jours de réserve ; laissez votre itinéraire et votre heure d'arrivée à quelqu'un en ville, et voyagez avec un second véhicule si possible *

PARTIELLEMENT CONFIRMÉ · ISSU DE L'ACTION 2

ÉCHÉANCE	COÛT POUR VOUS	PROTÈGE

* Formulation suggérée : à vérifier auprès d'un agent de santé avant diffusion

à chaque voyage, à partir de mars 2027	l'eau et les récipients	toutes les personnes à bord

Le 4 juin 2026, 49 personnes sont mortes de soif à environ 80 km à l'ouest d'Assamaka après la panne de leur camion. C'étaient des travailleurs nigériens de sites aurifères qui rentraient du Mali pour l'Aïd. Deux survivants sont partis à pied chercher de l'aide, et la patrouille venue à leur secours a ensuite trouvé un second camion bloqué depuis trois jours et sauvé ses 60 passagers. Par une chaleur supérieure à 40 °C, 10 litres ne permettent de survivre qu'un à deux jours.*

Ce qu'il faut demander aux responsables

- Demander à la Direction régionale de la santé publique (DRSP) : « Notre CSI aura-t-il de la ceftriaxone en stock d'ici le 15 décembre ? » (action 1).
- Demander au gouvernorat et à la Protection civile : « Quel est le numéro unique à appeler quand un véhicule est bloqué dans le désert ? » (action 2).
- Demander à la DRSP, à la Direction de la météorologie nationale (DMN) et aux radios : « Les alertes chaleur seront-elles diffusées en haoussa et en tamasheq d'ici le 1er mars ? » (action 3).

CE QUE CETTE LOCALITÉ DEVRAIT FAIRE — PAR ORDRE DE PRIORITÉ

Classées selon le nombre de vies qu'elles devraient sauver par unité d'effort avant le pic. Les éclairages experts qui soutiennent chaque action

* Formulation suggérée : à vérifier auprès d'un agent de santé avant diffusion

sont indiqués ; une action à laquelle plusieurs éclairages sont parvenus indépendamment est le pari le plus sûr.

1. Méningite : d'ici le 15 décembre, constituer des stocks de traitement et de tests rapides dans chaque formation sanitaire, vérifier la couverture vaccinale de l'an dernier et rattraper les enfants non vaccinés, et tenir prête la demande de vaccins d'urgence

PARTIELLEMENT CONFIRMÉ · GESTIONNAIRE D'URGENCE · SANTÉ PUBLIQUE · HISTORIEN · PHILANTHROPE · SCEPTIQUE

ADAPTATION INVENTORY : NON CONSULTABLE

RESPONSABLE	ÉCHÉANCE	COÛT	PRÉVIENT
DRSP d'Agadez, avec le CHR et l'OMS/UNICEF	15 décembre 2026 ; surveillance hebdomadaire de cette date jusqu'en mai	3 000 000 à 5 871 400 FCFA (5 110 à 10 000 USD), en nature par l'OMS/UNICEF	les décès par méningite dus à un traitement tardif

La DRSP constitue des stocks de ceftriaxone et de tests rapides au Centre hospitalier régional (CHR), dans chaque CSI de la commune et à Assamaka, et assure une surveillance hebdomadaire par aire de santé. Elle vérifie, par aire de santé, la couverture en Men5CV de la campagne de novembre–décembre 2025 et administre des doses de rattrapage aux 1–19 ans non vaccinés dans le cadre des services de routine. La demande de vaccins d'épidémie au Groupe international de coordination (ICG) est rédigée à l'avance, afin de pouvoir partir dans les 48 heures suivant le franchissement du seuil épidémique. À Katsina, au Nigeria, en 1996, le traitement coûtait environ 232 500 FCFA (396 USD) par décès évité, contre environ 3,5 millions de FCFA (6 000 USD) pour une vaccination lancée avec six semaines de retard (Veeken, Ritmeijer et Hausman, Bull WHO 1998). Une simulation sur des données nigériennes a montré que la surveillance par aire de santé était la plus efficace, et qu'agir deux semaines plus tôt doublait l'efficacité (Maïnassara et al. 2015). En 2024, Agadez avait le deuxième taux d'attaque du Niger, 11,5 pour 100 000 ; à l'échelle nationale, 123 des 2 012 cas sont décédés (6,1 %).

Corrigé lors de la vérification : pas de nouvelle campagne de masse. Le Niger a déjà mené la première campagne préventive de Men5CV soutenue par Gavi, couplée au vaccin contre la typhoïde, pour les 1–19 ans sur l'ensemble du territoire en novembre–décembre 2025 (12,3 millions de personnes, OMS, WER 101(38), 25 septembre 2026) ; la région d'Agadez est probablement couverte, mais n'est pas citée. Le chiffre de Katsina est exprimé en dollars de 1996 et porte sur le sérogroupe A et le chloramphénicol huileux ; il faut donc l'utiliser

* Formulation suggérée : à vérifier auprès d'un agent de santé avant diffusion

comme un rapport, et non comme un prix. La simulation portait sur Tahoua, Tillabéri et Dosso, et non sur Agadez. La diphtérie est également active : 242 des 949 cas du Niger en 2026, jusqu'à la semaine 38, se trouvaient à Agadez (rapport secondaire citant l'OMS AFRO, non vérifié à la source).

2. Convenir d'ici le 1er décembre d'un numéro d'alerte unique pour les détresses dans le désert et, à partir du 1er mars, garder à Assamaka et à Arlit un véhicule d'astreinte avec le plein de carburant, pour tous ceux qui voyagent dans le désert ; apporter aux personnes expulsées une aide de base sans conditions

PARTIELLEMENT CONFIRMÉ · GESTIONNAIRE D'URGENCE · INTERVENANT DE TERRAIN · SCEPTIQUE · SANTÉ PUBLIQUE · PHILANTHROPE

ADAPTATION INVENTORY : NON CONSULTABLE

RESPONSABLE	ÉCHÉANCE	COÛT	PRÉVIENT
Gouvernorat d'Agadez, avec la Protection civile, Alarme Phone Sahara et l'OIM	numéro d'alerte le 1er décembre 2026 ; véhicule d'astreinte à partir du 1er mars 2027	gazole, environ 700 000 FCFA (1 192 USD) ; 2 000 couvertures et nattes, environ 10 millions de FCFA (17 032 USD) ; deux estimations	les décès de soif après une panne, tant que personne ne sait qu'un véhicule a disparu

Les 49 décès du 4 juin 2026 ont suivi une panne dont personne n'a rien su avant que deux survivants ne sortent du désert à pied ; la même patrouille a ensuite sauvé 60 personnes d'un second camion. Un numéro convenu et un véhicule prêt à partir réduisent ce délai. Les expulsions d'Algérie vers le Niger ont atteint le record de 34 236 personnes en 2025 (Alarme Phone Sahara), après 31 404 en 2024, alors que le budget de l'OIM a baissé d'environ 30 % en 2025. De décembre à février, des couvertures et des nattes pour les personnes expulsées qui arrivent sans rien constituent une aide de base.

Corrigé lors de la vérification : les morts de juin 2026 étaient des travailleurs nigériens de sites aurifères qui rentraient de Harouba, au Mali, et non des migrants expulsés ; le véhicule sert donc tous les voyageurs du désert. Aucun décès par hypothermie n'est documenté chez les personnes expulsées (minimale moyenne de janvier d'environ 13,5 °C ; le record de froid est contesté) ; les couvertures relèvent

* Formulation suggérée : à vérifier auprès d'un agent de santé avant diffusion

donc de l'aide, et non d'une mesure dont l'effet sur la survie est prouvé. Médecins du Monde a travaillé à Agadez de 2014 jusqu'à l'afflux de 2025, et la présence de MSF est documentée à Assamaka, mais la situation de l'une et l'autre organisation en 2026 n'a pas pu être confirmée : vérifier leur autorisation avant de les citer. Au-delà de l'estimation de gazole, le véhicule n'est pas financé.

3. Mettre en place d'ici le 1er mars un plan chaleur qui fonctionne sans le réseau électrique : un déclencheur fondé sur les prévisions, des SRO, une salle de triage rafraîchie avec alimentation de secours, une action de proximité auprès des personnes les plus exposées, et des messages radio en haoussa et en tamasheq

PARTIELLEMENT CONFIRMÉ · SANTÉ PUBLIQUE · GESTIONNAIRE D'URGENCE · PHILANTHROPE · INTERVENANT DE TERRAIN · SCEPTIQUE

ADAPTATION INVENTORY : NON CONSULTABLE

RESPONSABLE	ÉCHÉANCE	COÛT	PRÉVIENT
DRSP d'Agadez et CHR, avec la Direction de la météorologie nationale (DMN)	1er mars 2027	1 500 000 à 8 807 100 FCFA (2 555 à 15 000 USD) ; aucun précédent de chiffrage au Sahel	les décès dus à la chaleur de mars à mai, dont 43 prévus pour le seul mois de mars

Un déclencheur fondé sur les prévisions de température maximale de la DMN ; un stock de SRO et une salle de triage rafraîchie au CHR, avec alimentation de secours solaire ou par groupe électrogène ; une action de proximité des CSI auprès des personnes hypertendues, des ménages avec des enfants de moins de cinq ans et des centres de transit. Le conseil est de boire, de mouiller la peau et les vêtements, de rester à l'ombre et de se reposer à la mi-journée. Les messages sont diffusés sur la radio d'État (ORTN, La Voix du Sahel) et les radios communautaires en haoussa, en tamasheq et en français, ainsi que par les imams et le sultanat de l'Aïr. En 2007, environ 36 % des adultes du Niger souffraient d'hypertension (enquête STEPS), et à Niamey, seules 3,4 % des personnes dépistées étaient traitées. Le plan d'action contre la chaleur d'Ahmedabad a évité environ 1 190 décès par an (IC à 95 % 162–2 218 ; Hess et al. 2018).

Transférabilité : faible. Ahmedabad est une mégapole indienne humide, et son effet les jours au-dessus de 40 °C (rapport des taux 0,95) n'était pas significatif. Aucun système opérationnel d'alerte chaleur-santé n'existe au Sahel (ACASIS était un projet pilote au Sénégal et au Burkina Faso ; une proposition de l'ECMWF de 2026 en piloterait un avec AGRHYMET) ; Agadez serait donc une première. Les chiffres sur

* Formulation suggérée : à vérifier auprès d'un agent de santé avant diffusion

l'hypertension proviennent de Niamey. Trois journalistes de la station locale Sahara FM ont fait l'objet d'une arrestation en mai 2025, et aucun signe de diffusion en 2026 n'a été trouvé : vérifier avant de la citer. Ne débloquer le montant supérieur que sur présentation d'un budget détaillé par ligne de la DRSP.

4. Éleveurs : agir sur les résultats fourragers et du Cadre Harmonisé de novembre : déstocker tôt et prépositionner l'aliment du bétail dès la pré-alerte de janvier, inscrire les ménages vulnérables sur toute liste, et plaider pour l'inclusion d'Agadez dans le Plan de soutien 2027

PARTIELLEMENT CONFIRMÉ · ÉCONOMISTE · HISTORIEN · ALIMENTATION · PHILANTHROPE · GESTIONNAIRE D'URGENCE · ADAPTATION INVENTORY : NON CONSULTABLE

RESPONSABLE	ÉCHÉANCE	COÛT	PRÉVIENT
Direction régionale de l'élevage et associations d'éleveurs, avec la Croix-Rouge nigérienne (CRN) à Agadez et les chefs de quartier et de village	**décision en décembre 2026 ; action à la pré-alerte de janvier**	**transferts monétaires pastoraux de 117 428 000 FCFA (200 000 USD), débloqués sur les résultats de novembre ; aliment du bétail non chiffré**	**l'effondrement des troupeaux et la faim de la soudure 2027 qui s'ensuit**

Le CILSS qualifie le déficit pastoral 2026 d'Agadez de « très marqué », et FEWS NET relie la mauvaise saison à El Niño. Au Niger, en 2010, le CICR, Oxfam et VSF-B ont acheté environ 36 000 têtes à des prix d'avant-crise, mais un atelier de capitalisation a conclu que l'action aurait dû commencer dès la pré-alerte de janvier, avec un aliment du bétail prépositionné ; 10 000 t d'aliment avaient été demandées pour 16 000 t nécessaires. Les transferts monétaires pastoraux proposés par le philanthrope (1 000 ménages à 117 428 FCFA chacun) comblent un vrai manque. Les débloquer sur les résultats fourragers et du Cadre Harmonisé de novembre, par l'intermédiaire de la CRN à Agadez.

Corrigé lors de la vérification, et les corrections sont importantes. Le protocole d'action précoce de la Croix-Rouge contre la sécheresse (FICR EAP2024NE04, valable cinq ans à partir de mai 2024) s'élève au total à 874 573 CHF (environ 612 millions de FCFA), dont 607 309 CHF (environ 425 millions de FCFA) pour l'action précoce. Son déclencheur fourrager de novembre verse 40 000 FCFA × 3 mois × 500 ménages, soit 60 millions de FCFA (102 000 USD), pour tout le Niger ; il ne cite aucune région, et aucune activation en 2025–2026 n'a été trouvée. Le cadre sécheresse du CERF de l'ONU n'a été activé qu'une fois, en 2022 (5,6 milliards de FCFA, 9,5 millions USD, sud-ouest du Niger) ; la couverture d'Agadez n'est pas vérifiée : interroger OCHA, mais ne pas compter sur des fonds. Aucune police de la Mutuelle

* Formulation suggérée : à vérifier auprès d'un agent de santé avant diffusion

panafricaine de gestion des risques (African Risk Capacity) n'a été trouvée pour le Niger en 2025–2027. Le Plan de soutien est établi à partir du Cadre Harmonisé de novembre et publié vers février ; le plan 2022 citait des communes d'Agadez, mais aucun plan 2026–2027 n'a été trouvé. En 2022, la CRN a atteint environ 6 000 des 22 000 ménages ciblés au niveau national ; sa capacité à absorber ces fonds est donc un risque. Le montant du transfert est une hypothèse, et l'aliment du bétail n'est pas chiffré, faute de prix de l'aliment à Agadez.

5. Compter les décès à partir de novembre : un décompte quotidien des inhumations dans les cimetières et un registre des décès au CHR, avec autopsie verbale à partir de mars

PARTIELLEMENT CONFIRMÉ | SCEPTIQUE · SANTÉ PUBLIQUE · HISTORIEN | ADAPTATION INVENTORY : NON CONSULTABLE

RESPONSABLE	ÉCHÉANCE	COÛT	PRÉVIENT
Commune urbaine d'Agadez (état civil), avec la DRSP	référence à partir de novembre 2026 ; causes de décès à partir de mars 2027	environ 1 500 000 à 2 935 700 FCFA (2 555 à 5 000 USD), estimation sans source	une saison chaude que personne ne peut voir, et des dépenses que personne ne peut évaluer

Ici, les décès dus à la chaleur sont enregistrés comme accidents vasculaires cérébraux, insuffisances rénales ou décès d'enfants, quand ils le sont. L'hôpital Gabriel Touré de Bamako a enregistré 102 décès du 1er au 4 avril 2024, contre 130 sur tout le mois d'avril 2023 ; le Niger n'a enregistré aucune surmortalité, parce que personne ne comptait. À Aden, une équipe qui comptait les inhumations sur des images satellite a estimé à environ 2 100 les inhumations excédentaires en 2020 (Koum Besson, Checchi et al., BMJ Global Health 2021). Agadez s'y prête : l'inhumation a lieu le jour même, et la ville compte peu de cimetières.

* Formulation suggérée : à vérifier auprès d'un agent de santé avant diffusion

Corrigé lors de la vérification : la cause des décès de Bamako n'a jamais été publiée ; ils ne doivent donc pas être qualifiés de décès dus à la chaleur. Un décompte des inhumations ne permet pas de distinguer la chaleur des autres causes ; l'autopsie verbale l'ajoute à partir de mars.

6. Alimentation : constituer un stock tampon de céréales contre une rupture de convoi ou de carburant, et donner la priorité aux camions de vivres pour le gazole et les places en convoi

PARTIELLEMENT CONFIRMÉ | ALIMENTATION · ÉCONOMISTE | ADAPTATION INVENTORY : NON CONSULTABLE

RESPONSABLE	ÉCHÉANCE	COÛT	PRÉVIENT
Gouvernorat d'Agadez, avec l'OPVN (Office des produits vivriers du Niger) et le DNPGCA	achats de novembre 2026 à janvier 2027 ; ventes d'avril à août 2027 selon le déclencheur de prix	environ 140 millions de FCFA (238 000 USD) pour 500 t de mil à environ 280 FCFA/kg, notre estimation ; une ligne de l'État, et non philanthropique	des marchés vides dans une ville située à 900 km, au bout d'une route qui dépend du gazole et des escortes

Agadez est un marché déficitaire : ses céréales arrivent par camion, et ses prix sont supérieurs à la moyenne nationale. Les 500 t représentent à peu près une semaine de consommation céréalière de la commune ; c'est donc un tampon contre une rupture de convoi ou de carburant, et non un levier sur les prix. Des ventes à prix modérés suivent d'avril à août (le pic de la soudure va de juin à août, et le mil a augmenté jusqu'à 25 % de mai à juillet, selon FAO SMIAR [GIEWS]), déclenchées lorsque le prix du mil relevé par le SIMA dans la commune d'Agadez dépasse 340 FCFA/kg, soit environ 15 % de plus que les 295 de juin (notre seuil). Les paniers alimentaires sont le bon outil ici : dans un essai à Zinder, ils ont fait mieux que les transferts monétaires sur la consommation, et moins de 5 % ont été revendus, même s'ils coûtaient 15 % de plus à distribuer (Hoddinott, Sandström et Upton 2018). Le déficit national de carburant de janvier à août 2026 s'élevait à 52,6 millions de litres de gazole et 196,6 millions de litres d'essence.

Corrigé lors de la vérification : l'interdiction d'exporter du carburant du 12 octobre résultait d'un arrêté du ministère du Commerce, qui aurait été retiré le 17 octobre, et l'approvisionnement de Niamey se normalisait le 23 octobre ; aucune source datée de 2026 sur le carburant à Agadez n'a été trouvée. Le bulletin du SIMA paraît avec environ une semaine de décalage, mais les bulletins de juillet à

* Formulation suggérée : à vérifier auprès d'un agent de santé avant diffusion

septembre 2026 manquent sur le site miroir public ; le responsable du déclencheur devrait donc les obtenir directement auprès du SIMA. Le tonnage et le seuil sont les nôtres et ne figurent dans aucun plan ; aucune vente à prix modérés de l'OPVN en 2025–2026 n'a été trouvée.

7. Malnutrition aiguë sévère : maintenir l'approvisionnement du traitement ambulatoire jusqu'en 2027, avec un dépistage dans les CSI en février

PARTIELLEMENT CONFIRMÉ | PHILANTHROPE · SANTÉ PUBLIQUE | ADAPTATION INVENTORY : NON CONSULTABLE

RESPONSABLE	ÉCHÉANCE	COÛT	PRÉVIENT
DRSP d'Agadez, avec l'UNICEF	affectation avant février 2027 ; dépistage par périmètre brachial (MUAC) en février	16 146 350 FCFA (27 500 USD) pour 500 traitements, hors transport à l'intérieur du pays	une rupture d'aliment thérapeutique après janvier 2027

L'aliment thérapeutique prêt à l'emploi (ATPE) du Niger est disponible jusqu'en janvier 2027 ; il n'y a donc pas de rupture en 2026, et les fonds couvrent le manque de 2027. Il s'agit de 500 traitements à environ 32 300 FCFA (55 USD) chacun, fret compris (UNICEF, T2 2026). Les affecter à la prise en charge ambulatoire dans les CSI et les CRENAS, et non aux CRENI en hospitalisation : au Bangladesh, la prise en charge communautaire coûtait 15 300 FCFA (26 USD) par DALY, contre 789 000 FCFA (1 344 USD) pour la prise en charge hospitalière (Puett et al. 2013).

* Formulation suggérée : à vérifier auprès d'un agent de santé avant diffusion

Corrigé lors de la vérification : Agadez n'est pas le foyer nutritionnel du Niger. L'enquête SMART 2025 a relevé dans la région d'Agadez 9,0 % de malnutrition aiguë [6,7–11,8], dont 0,8 % de malnutrition aiguë sévère, le taux de forme sévère le plus bas du Niger (moyenne nationale de 11,1 % et 2,8 %). Le nombre de 500 enfants est une estimation raisonnable, et non un décompte.

8. Profiter de la saison sèche pour inspecter le barrage de la Telwa et les digues de protection d'ici février, et les réparer avant juillet 2027

PARTIELLEMENT CONFIRMÉ | HISTORIEN · INTERVENANT DE TERRAIN · GESTIONNAIRE D'URGENCE | ADAPTATION INVENTORY : NON CONSULTABLE

RESPONSABLE	ÉCHÉANCE	COÛT	PRÉVIENT
Commune urbaine d'Agadez, avec la Direction régionale de l'hydraulique	**inspection d'ici le 28 février 2027 ; réparation avant juillet 2027**	**non chiffré ; non financé**	**une répétition de la rupture de 2009 lors de la prochaine saison des pluies**

Le 1er septembre 2009, le barrage de la Telwa, à environ 7 km de la ville, a cédé après des pluies exceptionnelles. Au moins 3 personnes sont mortes (les habitants ont parlé de dizaines), et environ 3 000 maisons ont été détruites (USAID) ; le gouvernement en a dénombré plus de 13 000 partiellement ou totalement détruites. ECHO a approuvé environ 587 millions de FCFA (1 million USD) et le PNUD 117 millions de FCFA (200 000 USD) pour la reconstruction. La vieille ville a de nouveau été inondée en septembre 2024 (environ 100 maisons et murs effondrés, la Grande Mosquée endommagée, 10 morts dans la région) et en juillet 2025 (2 morts). La commune devrait demander au projet PIDUREM de la Banque mondiale (P175857) si les réparations entrent dans son champ ; il ne finance actuellement qu'une étude de schéma directeur d'assainissement pluvial d'Agadez, d'environ 57,5 millions de FCFA (98 000 USD).

Non vérifié : aucun élément n'indique que le barrage a été reconstruit ou inspecté depuis 2009. Cette action protège davantage la saison des pluies 2027 que cet hiver.

* Formulation suggérée : à vérifier auprès d'un agent de santé avant diffusion

QUI FAIT QUOI

MATRICE RACI

R = Réalise (exécute le travail) · **A** = Approuve (un seul par action ; valide et en répond) · **C** = Consulté (sollicité avant) · **I** = Informé (tenu au courant après). Établie à partir des responsables désignés dans les actions vérifiées. Personne ici n'a été contacté ni n'a accepté de rôle ; chaque ligne est une proposition.

Action	DRSP et CHR	OMS et UNICEF	Gouvernorat d'Agadez	Protection civile	Partenaires d'aide aux migrants (OIM, Alarme Phone Sahara, MdM/MSF)	DMN	Commune urbaine d'Agadez	Chefs, imams, sultanat et radios	Direction de l'élevage et associations d'éleveurs	CRN Agadez	OPVN et DNPGCA	Direction régionale de l'hydraulique
1. Stocks contre la méningite, rattrapage, dossier ICG	**A/R**	**R**	**I**		**C**			**I**				
2. Numéro d'alerte désert et véhicule d'astreinte	**C**		**A**	**R**	**R**		**I**	**I**				
3. Plan chaleur sans réseau électrique	**A/R**	**C**	**I**		**I**	**R**	**C**	**R**				
4. Éleveurs : déstockage, aliment du bétail, listes			**C**					**R**	**A/R**	**R**	**C**	
5. Compter les décès	**R**		**I**				**A/R**	**C**				
6. Stock tampon de céréales et priorité pour le gazole			**A**				**I**	**I**			**R**	
7. Approvisionnement contre la malnutrition	**A/R**	**R**						**C**				
8. Barrage de la Telwa et digues			**C**	**C**			**A**					**R**

Ce que montre la matrice : la DRSP approuve trois des huit actions (méningite, chaleur et malnutrition), le cœur de ce qui sauve des vies. Le gouvernorat en approuve deux (le protocole désert et le stock tampon de céréales) et est informé de la plupart des autres. Les actions 2, 4 et 6 dépendent de décisions (un numéro convenu, une liste de bénéficiaires, une priorité pour le carburant) plus que d'argent.

OÙ L'ARGENT EST LE PLUS UTILE

FINANCEMENT

L'éclairage du philanthrope, rapproché des actions classées et vérifié. Les affectations sont classées selon les vies supplémentaires sauvées par dollar. L'enveloppe est limitée par ce que la localité peut dépenser avant le pic, et non par ses besoins.

PLANCHER

22 017 750 FCFA (37 500 USD)

OBJECTIF

51 374 750 FCFA (87 500 USD)

PLAFOND

168 802 750 FCFA (287 500 USD)

PRINCIPALE INCERTITUDE

le nombre de cas (aucun décompte de la méningite à Agadez pour 2025–2026) et les ONG encore autorisées

* Formulation suggérée : à vérifier auprès d'un agent de santé avant diffusion

Plancher = affectations 1 + 2 : 5 871 400 FCFA + 16 146 350 FCFA = 22 017 750 FCFA (37 500 USD). Objectif = plancher + affectations 3 à 5 : + 8 807 100 FCFA + 17 614 200 FCFA + 2 935 700 FCFA = 51 374 750 FCFA (87 500 USD). Plafond = objectif + affectation 6, 117 428 000 FCFA = 168 802 750 FCFA (287 500 USD). Au-delà du plafond, la limite tient à qui est autorisé à dépenser : le CICR a quitté le Niger (fermeture annoncée le 5 juin 2025), et le nombre d'ONG enregistrées est passé de 4 700 à 1 800 (ministère de l'Intérieur, 22 avril 2026), sans liste publique de celles qui ont été suspendues. L'objectif a augmenté de 13 % lors de la vérification (depuis 45 503 350 FCFA, 77 500 USD), surtout parce que le prix unitaire de l'ATPE est passé à environ 32 300 FCFA (55 USD) et que le décompte des décès a été ajouté. Déjà financé, à ne pas dupliquer : le plan humanitaire 2025 était financé à environ 18,5 % (aucun chiffre 2026 confirmé), et l'allocation inondations du CERF de janvier 2026 (2,94 milliards de FCFA, 5 millions USD) n'est allée qu'à Dosso et à Tillabéri. Lignes de l'État, non philanthropiques : le stock tampon de céréales de l'OPVN (action 6) et le Plan de soutien. Non financés : l'inspection et la réparation du barrage (action 8) et le véhicule du désert au-delà de son gazole (action 2). Plaidoyer, et non financement pour cette période : la région d'Agadez attend 5,50 milliards de FCFA (9,4 millions USD) d'arriérés de redevances minières pour 2014–2018 (étude ROTAB/PCQVP, 2019, hébergée par l'ITIE) ; aucun paiement n'a été trouvé en 2025–2026.

BÉNÉFICIAIRE	UTILISATION	MONTANT	MÉCANISME	FONDEMENT	VERDICT
DRSP d'Agadez et CHR	Action 1 : stock pour la prise en charge des cas de méningite	5 871 400 FCFA (10 000 USD)	en nature par l'OMS/UNICEF	Traitement : 232 500 FCFA (396 USD) par décès évité, contre 3,5 millions de FCFA (6 000 USD) pour une vaccination tardive (Veeken 1998, Katsina ; à utiliser comme rapport)	Partiellement confirmé
Chaîne d'approvisionnement de l'UNICEF, affectée aux CRENAS et aux CSI	Action 7 : ATPE, 500 traitements	16 146 350 FCFA (27 500 USD)	contribution affectée	Environ 32 300 FCFA (55 USD) par carton, fret compris (UNICEF T2 2026) ; 15 300 FCFA (26 USD) par DALY pour la prise en charge communautaire (Puett 2013)	Partiellement confirmé

* Formulation suggérée : à vérifier auprès d'un agent de santé avant diffusion

BÉNÉFICIAIRE	UTILISATION	MONTANT	MÉCANISME	FONDEMENT	VERDICT
DRSP et CHR	Action 3 : alerte chaleur, SRO, salle de triage avec alimentation de secours	jusqu'à 8 807 100 FCFA (15 000 USD)	subvention sur budget détaillé par ligne	Aucun précédent au Sahel ; Ahmedabad n'est pas transposable	Non vérifié (montant supérieur)
Médecins du Monde (ou MSF)	Action 2 : soins et aide de base pour les migrants et les voyageurs du désert	17 614 200 FCFA (30 000 USD)	par tranches ; preuve préalable d'une autorisation en cours de validité du ministère de l'Intérieur	Environ 11 839 migrants servis en 2024 ; activité en 2026 non vérifiée	Partiellement confirmé
État civil de la commune et DRSP	Action 5 : décompte des décès, novembre–mai	jusqu'à 2 935 700 FCFA (5 000 USD)	petite subvention	Estimation sans source (enquêteurs, registres, crédit téléphonique)	Partiellement confirmé
Croix-Rouge nigérienne, Agadez	Action 4 : transferts monétaires pastoraux, 1 000 ménages × 117 428 FCFA	117 428 000 FCFA (200 000 USD)	transfert monétaire, débloqué sur les résultats fourragers et du Cadre Harmonisé de novembre	Montant du transfert supposé ; la CRN a atteint environ 6 000 des 22 000 ménages ciblés en 2022	Partiellement confirmé

Le point de vue d'un bailleur : ici, la vie la moins chère à sauver coûte environ 235 000 FCFA (400 USD) d'antibiotiques déjà présents au CSI en janvier, et non une campagne de vaccination en avril. La contrainte déterminante n'est pas l'argent, mais la liste des organisations encore autorisées à le dépenser. Financer la DRSP et les structures qui ont survécu aux suspensions de 2025 avant toute initiative nouvelle.

* Formulation suggérée : à vérifier auprès d'un agent de santé avant diffusion

À ne pas faire

CONTRE-INDIQUÉ · DES CONSEILS QUI COÛTERAIENT DES VIES ICI

Des conseils qui circulent face à cet aléa et qui coûteraient des vies ici. La seconde étiquette de chaque fiche indique dans quelle mesure l'avertissement lui-même a été vérifié.

Dire aux éleveurs que l'argent du protocole sécheresse va arriver

CONTRE-INDIQUÉ RELEVÉ LORS DE LA VÉRIFICATION (UNE ÉTAPE DESTINÉE AUX HABITANTS, À L'ÉTAT DE PROJET)

Les transferts de novembre du protocole sécheresse de la Croix-Rouge atteignent 500 ménages dans tout le Niger, ne citent aucune région, et leurs bénéficiaires sont ciblés à l'avance par les structures communautaires locales. Un habitant qui se renseigne sur le chiffre fourrager ne le fait pas bouger. Un éleveur qui attend l'argent au lieu de vendre perd les animaux et le prix.

À la place : demander à la CRN et à votre chef de quartier ou de village si une liste est en préparation, et vendre de toute façon les animaux faibles (action 4).

Conditionner l'hébergement ou l'aide aux migrants expulsés à l'acceptation du « retour volontaire », ou remettre à la police la liste des concessions où vivent les migrants

CONTRE-INDIQUÉ CONFIRMÉ

L'OIM admet dans son centre d'Assamaka les personnes qui souhaitent un retour assisté, et en 2023, moins de 15 % des arrivants y ont trouvé un abri (MSF, Alarme Phone Sahara). Des personnes retenues pendant des mois dans les centres d'Agadez et d'Arlit ont manifesté en 2022. Les migrants en transit vivent à l'abri des regards dans des concessions tenues par des passeurs (« ghettos ») ; si leur emplacement est transmis à la police, les portes se ferment aussi aux agents de santé (éclairage de l'intervenant de terrain, non vérifié séparément).

* Formulation suggérée : à vérifier auprès d'un agent de santé avant diffusion

À la place : un hébergement, de l'eau et des soins sans conditions, et des listes de concessions conservées uniquement par Alarme Phone Sahara et la formation sanitaire (action 2).

Attendre le seuil épidémique pour préparer la riposte à la méningite

CONTRE-INDIQUÉ CONFIRMÉ

Au Niger, la vaccination réactive arrive souvent trop tard : une étude des épidémies à sérogroupe C de 2015 a conclu que les stratégies réactives avaient eu peu d'impact (Trop Med Int Health 2017), et dans une simulation sur des données nigériennes, agir deux semaines plus tôt doublait l'efficacité (Maïnassara et al. 2015).

À la place : des stocks de traitement dans chaque CSI d'ici le 15 décembre et le dossier ICG prêt à envoyer (action 1).

Attendre la soudure pour vendre les animaux faibles

CONTRE-INDIQUÉ CONFIRMÉ DANS SON ORIENTATION

En 2010, les éleveurs qui ont attendu ont vendu sur un marché du bétail en baisse pendant que le prix des céréales montait. En juin 2026, une chèvre permettait encore d'acheter environ une unité de mil (termes de l'échange de 0,99) ; ce rapport se dégrade au fil de la saison sèche.

À la place : vendre entre novembre et janvier, et acheter des céréales avec le produit de la vente.

Distribuer ou conseiller des ventilateurs pour les personnes âgées ou malades par la chaleur sèche d'Agadez*

CONTRE-INDIQUÉ PARTIELLEMENT CONFIRMÉ

Meade, Notley, Kirby et Kenny (Lancet Planetary Health, 2024) déconseillent les ventilateurs au-dessus de 35 °C, en particulier pour les plus de 65 ans. Morris et al. (2021) ont modélisé des seuils de 39 °C pour les jeunes adultes, 38 °C pour les personnes âgées et 37 °C pour les personnes âgées sous médicaments anticholinergiques. Dans un essai publié dans le JAMA chez des personnes âgées, les

* Formulation suggérée : à vérifier auprès d'un agent de santé avant diffusion

ventilateurs n'ont pas abaissé la température centrale par chaleur extrême. En avril–mai, Agadez connaît environ 40 à 43 °C avec une humidité inférieure à 20 %. Donc : pas de ventilateur au-dessus d'environ 35 °C pour les plus de 65 ans ; le seuil modélisé est de 37–38 °C.

À la place : mouiller la peau et les vêtements, l'ombre et l'eau (action 3).

Construire le plan chaleur autour de la climatisation

`CONTRE-INDIQUÉ` `PARTIELLEMENT CONFIRMÉ`

Agadez est alimentée par la centrale à charbon de la SONICHAR et n'est pas reliée à la ligne d'importation en provenance du Nigeria ; aucune donnée de coupures pour la ville en 2025–2026 n'a été trouvée, si bien que l'argument repose sur le coût et l'échelle, et non sur des coupures documentées. Lors de la vague de chaleur d'avril 2024 au Sahel, les coupures de courant ont rendu difficile l'usage de la climatisation pour ceux qui en disposaient.

À la place : des pièces ombragées, et toute salle rafraîchie dotée d'une alimentation de secours solaire ou par groupe électrogène (action 3).*

Envoyer les alertes chaleur ou sanitaires uniquement par SMS en français

`CONTRE-INDIQUÉ` `NON VÉRIFIÉ EN TANT QU'ÉCHEC DOCUMENTÉ ICI`

La plupart des habitants parlent le haoussa ou le tamasheq, et beaucoup des personnes les plus exposées, migrants et personnes âgées, ne sont pas atteintes par des SMS en français. Les alertes inondations du Niger sont déjà diffusées à la radio en langues locales (PAM).

À la place : la radio en haoussa et en tamasheq, les imams et les chefs de quartier (action 3).

* Formulation suggérée : à vérifier auprès d'un agent de santé avant diffusion

ANNÉE	ÉVÉNEMENT	BILAN	CE QUI A CHANGÉ ENSUITE
1969–1984	Longue sécheresse au Sahel : Agadez a perdu l'équivalent de 6,8 années normales de pluie ; les troupeaux se sont effondrés en 1973 et en 1984, chaque fois lors de la deuxième année sèche	Aucun bilan des décès trouvé ; des milliers de familles nomades se sont installées en périphérie d'Agadez	La frange sédentaire de la ville en est issue
2009	Saison de méningite	189 cas et 16 décès dans la région ; 99 cas et 4 décès en ville (source secondaire)	Non documenté
1er septembre 2009 (El Niño)	Rupture du barrage de la Telwa après des pluies exceptionnelles	Au moins 3 morts (les habitants ont parlé de dizaines) ; environ 3 000 maisons détruites (USAID), plus de 13 000 partiellement ou totalement (gouvernement)	Réparation du barrage citée en priorité ; fonds d'ECHO et du PNUD approuvés ; aucune reconstruction trouvée
2009–2010 (El Niño)	Deuxième mauvaise année pastorale et crise alimentaire	2,7 millions de Nigériens en insécurité alimentaire sévère en mars 2010 ; malnutrition aiguë supérieure à 17 % dans certaines parties d'Agadez fin 2010	Crise reconnue plus tôt qu'en 2005 ; déstockage encore tardif
2015	Épidémie de méningite à sérogroupe C, Niger	8 500 cas et 573 décès au niveau national	Vaccination réactive, jugée de peu d'impact
2024 (El Niño)	Méningite ; vague de chaleur d'avril au Sahel, jusqu'à 48 °C dans la région	Taux d'attaque à Agadez de 11,5 pour 100 000, deuxième du Niger ; décès dus à la chaleur non enregistrés au Niger	Riposte vaccinale dans cinq districts ; introduction du Men5CV
Septembre 2024	Inondations de la vieille ville	Environ 100 maisons et murs effondrés, Grande Mosquée endommagée ; 10 morts dans la région	Rien trouvé

* Formulation suggérée : à vérifier auprès d'un agent de santé avant diffusion

ANNÉE	ÉVÉNEMENT	BILAN	CE QUI A CHANGÉ ENSUITE
Juillet 2025	Inondations	2 morts	Rien trouvé
2025	Expulsions record depuis l'Algérie ; campagne préventive nationale de Men5CV (novembre–décembre)	34 236 personnes expulsées ; 7 décès liés aux expulsions (Alarme Phone Sahara)	12,3 millions de personnes vaccinées, de 1 à 19 ans
4 juin 2026	Panne de camion à l'ouest d'Assamaka	49 morts de soif ; 60 personnes secourues d'un second camion	Aucun protocole trouvé
2026	Diphtérie ; déficit pastoral « très marqué »	242 des 949 cas nationaux de diphtérie jusqu'à la semaine 38 (source secondaire)	Pas encore

La récurrence que personne n'a relevée : ici, les décès dus à El Niño surviennent l'année suivante. 1973, 1984, 2005 et 2010 ont chacune été la deuxième année d'une crise, celle de la soudure. L'El Niño de 2009 a apporté à Agadez une inondation cet automne-là, puis sa pire malnutrition l'année suivante. La facture des pâturages déficitaires de 2026 arrivera entre mai et août 2027, après le pic d'El Niño et après la fin de la période couverte par le tracker.

LÀ OÙ LES EXPERTS DIVERGENT — NON RÉSOLU

- **Vacciner de façon préventive par aire de santé en décembre–janvier** (Sceptique) ou **la campagne a déjà eu lieu** (vérification : Men5CV pour les 1–19 ans, sur l'ensemble du territoire, novembre–décembre 2025). Le classement ne retient que les doses de rattrapage ; une vérification de la couverture par district permettrait de savoir si Agadez a besoin de davantage.
- **Les couvertures pour les personnes expulsées sauvent des vies** (Gestionnaire d'urgence) ou **aucun décès dû au froid n'est documenté parmi elles** (vérification). Maintenu comme aide de base, et non classé comme mesure qui sauve des vies.
- **Acheter des céréales pour contenir les prix** (Alimentation) ou **500 t représentent environ une semaine de consommation** (vérification). Maintenu comme tampon contre une rupture de convoi.
- **Recouvrer les arriérés de redevances minières pour financer les risques** (Économiste) ou **impayés depuis plus de sept ans, ce n'est donc pas de l'argent mobilisable pour cette période** (vérification). Maintenu comme plaidoyer.

* Formulation suggérée : à vérifier auprès d'un agent de santé avant diffusion

- **La ville compte plus de 300 000 habitants** (une ancienne autorité municipale, citée par les missionnaires comboniens, 2026) ou **les projections officielles sont bien inférieures**. Un recensement permettrait de trancher ; d'ici là, aucune part de la ville dans les décès régionaux n'est donnée.

CE QUE PERSONNE N'A TRAITÉ — ANGLE MORT

Aucun éclairage n'a interrogé qui que ce soit à Agadez. Rien n'a été trouvé sur les travailleurs des sites aurifères qui rentraient de Djado ou de Tchibarakaten en 2025–2026, alors que les morts de juin 2026 étaient des travailleurs de sites aurifères. Aucune donnée sur les coupures d'électricité à Agadez, aucune information sur la situation actuelle de Sahara FM et aucun nom de quartier vérifié n'ont été trouvés. La soudure 2027 (mai–août) se situe hors de la période du tracker et constitue probablement le risque de mortalité le plus important.

COMMENT LIRE CETTE NOTE — MÉTHODE

Le panel a été constitué par l'auteur. Huit éclairages d'experts simulés ont servi à formuler ces recommandations. Lorsqu'ils concordent, il s'agit d'une hypothèse solide, et non d'un consensus de la discipline. Chaque recommandation a ensuite été vérifiée de façon indépendante quant aux preuves, à la transférabilité à cette localité et à la faisabilité avant le pic ; les étiquettes de verdict en rendent compte.

Les chiffres de mortalité sont publiés à l'échelle de la région, pour la région d'Agadez. Ce ne sont pas des chiffres propres à la ville. La projection El Niño ne couvre que *la chaleur* ; la sécheresse, les inondations, les incendies, la fumée et les mauvaises récoltes s'y ajoutent et sont traitées ici à partir de l'historique plutôt que d'un chiffre publié.

COMMENT CETTE NOTE A ÉTÉ PRODUITE — MÉTHODOLOGIE

- **Périmètre.** La localité a été prise telle qu'indiquée : la ville d'Agadez (commune urbaine d'Agadez), chef-lieu de la région d'Agadez, Niger. Les chiffres de mortalité n'existent qu'à l'échelle régionale ; les données propres à la ville servent à l'exposition aux aléas et à la conception des actions, et non au décompte des décès. La population de la ville est contestée ; aucune part de la ville dans le chiffre régional n'est donc donnée.
- **Exposition.** Données du El Niño Heat Mortality Tracker du Climate Impact Lab, fichier `v261026_adm1_output_BASE_rounded_cust.csv` (version du 26 octobre 2026, avant évaluation par les pairs) : région d'Agadez (GADM NER.1_1), 310 décès supplémentaires dus à la chaleur de juin à septembre 2026, 93 prévus d'octobre 2026 à mars 2027 (octobre 24, novembre 20, décembre 0, janvier 3, février 4, mars 43), soit

* Formulation suggérée : à vérifier auprès d'un agent de santé avant diffusion

410 au total ; Niger, 10 600 ; monde, 857 400. Cette mise à jour remplace le rapport de septembre *451,000 at Risk*. Méthode : prévisions saisonnières ECMWF SEAS5 appliquées aux relations température–mortalité par rapport à une référence 1996–2025. Les chiffres ne comptent que la chaleur ; nous l'avons déduit des données, car les pays froids affichent exactement zéro chaque mois d'hiver. Ils ne sont jamais ajoutés aux projections à long terme de l'Impact Map.

- **Panel d'experts.** Huit éclairages d'experts simulés (gestionnaire d'urgence, spécialiste de santé publique, intervenant de terrain, sceptique, économiste, historien, philanthrope et analyste de la chaîne d'approvisionnement alimentaire) ont chacun étudié cette localité de façon indépendante et en parallèle, à partir de sources en ligne en français et en anglais, selon un cahier des charges fixe.
- **Rapprochement.** Les actions en double ont été fusionnées et les éclairages qui les soutiennent consignés. La convergence a été testée au regard d'un biais commun (les preuves à l'appui d'une action partagée provenaient-elles d'un contexte semblable à celui-ci ?) avant d'être retenue en faveur d'une action. Les contradictions ont été conservées, et non tranchées en écartant l'un des avis. Les actions ont été classées selon le nombre de vies qu'elles devraient sauver par unité d'effort avant le pic ; chacune s'est vu attribuer un payeur désigné et un déclencheur, ou a été marquée non financée, et les affectations de financement ont été rapprochées de la liste classée. Les arriérés de redevances minières ont été retirés des actions et conservés comme demande de plaidoyer.
- **Vérification.** Cinq agents vérificateurs (méningite ; instruments financiers ; migrants et chaleur ; alimentation et nutrition ; enveloppe de financement, décompte des décès et barrage) ont examiné chaque recommandation selon trois critères : les preuves (la source primaire et l'ampleur de l'effet), la transférabilité (ces preuves proviennent-elles d'un contexte comparable ?) et la faisabilité (peut-on la mettre en œuvre ici avant le pic ?). Les actions financières ont en outre été vérifiées quant à leur disponibilité dans cette juridiction, à l'existence d'un payeur désigné et d'un seuil de déclenchement, et à leur éventuelle existence préalable ; les actions alimentaires, quant aux déclencheurs publiés et au calendrier. L'enveloppe de financement a été vérifiée quant à la réalité des bénéficiaires, aux coûts unitaires publiés et aux doublons, puis recalculée. Les 9 étapes de la rubrique « Pour vous » ont été vérifiées selon les mêmes critères, appréciés du point de vue d'un habitant.
- **Qui fait quoi.** La matrice RACI est établie à partir des responsables désignés dans les actions vérifiées, avec une seule partie qui approuve par action. Il s'agit d'une proposition : aucune organisation qui y figure n'a été contactée ni n'a accepté de rôle.
- **Verdicts.** *Confirmé* : preuves, transférabilité et faisabilité sont toutes établies. *Partiellement confirmé* : établi après les corrections indiquées. *Non vérifié* : n'a pas pu être rattaché à une source primaire. *Contre-indiqué* : serait nuisible ou gaspillerait la fenêtre d'action ici.
- **Adaptation Inventory.** Non utilisable lors de cette analyse. L'inventaire s'affiche dans le navigateur et n'a renvoyé aucune entrée à l'outil de récupération des agents ; aucun précédent n'a donc pu y être confirmé. Aucune action ici ne doit être lue comme sans précédent ; aucune n'a été vérifiée.

* Formulation suggérée : à vérifier auprès d'un agent de santé avant diffusion

- **Montants.** Les coûts sont exprimés en francs CFA d'Afrique de l'Ouest (FCFA, code XOF), avec l'équivalent en dollars américains (USD) entre parenthèses, au taux de 587,14 FCFA = 1 USD. Ce taux découle de la parité fixe de 655,957 FCFA = 1 € et du taux de référence de la BCE de 1 € = 1,1172 USD (30 octobre 2026). Les montants publiés en francs suisses (protocoles de la Croix-Rouge) sont convertis à environ 700 FCFA pour 1 CHF, approximation obtenue par la parité avec l'euro.
- **Lecteur.** Aucun rôle n'ayant été indiqué, la rubrique « Pour vous » s'adresse à un habitant. Ses étapes sont tirées des actions vérifiées et de ce que le panel a appris sur les ménages d'ici. Toute étape qui ne découle pas d'une action classée a été vérifiée selon les trois mêmes critères ; deux d'entre elles (le réchaud et la réserve d'eau) n'ont pas pu l'être, et sont signalées comme conseils généraux de sécurité. Le reste du rapport s'adresse à la région et à ses partenaires.
- **Langue.** Cette version française accompagne la version anglaise, le français étant la langue de l'administration nigérienne. La plupart des habitants d'Agadez parlent le tamasheq ou le haoussa. Une version en haoussa a été ajoutée le 31 octobre 2026 ; aucune version n'a été produite en tamasheq, et l'action 3 demande que les messages clés soient diffusés à la radio dans les deux langues. Les passages marqués « suggested formulation » sont des consignes de sécurité traduites qu'aucun agent de santé de langue maternelle française n'a encore vérifiées.
- **Formulations de santé.** Les passages où une erreur de formulation pourrait nuire à quelqu'un (fraîcheur et ventilateurs, médicaments et doses, traitement de l'eau et SRO, signes de danger, réserves d'urgence et moment où demander de l'aide) sont signalés par « * Formulation suggérée : à vérifier auprès d'un agent de santé avant diffusion ». Ils ont été vérifiés à partir de sources publiées, et non par un professionnel de santé. Ce sont des suggestions, pas des avis médicaux : toute personne qui les relaie doit d'abord les confirmer auprès d'un médecin, d'un pharmacien, d'un infirmier ou d'un agent de santé communautaire. Ce marquage a été ajouté le 2 novembre 2026.
- **Règles.** Aucun coût n'est obtenu en divisant un total publié, et aucun chiffre local n'est inventé ; lorsque les données sont rares, le rapport le signale et donne le chiffre de l'échelon géographique supérieur, avec le calcul. Nos propres estimations (le tonnage de céréales et le seuil de prix, le montant des transferts pastoraux, le coût du décompte des décès et celui du véhicule) sont signalées comme telles. Chaque source est répertoriée ci-dessous avec son statut de vérification.
- **Limites.** Le panel et les vérificateurs sont des agents de recherche d'IA travaillant à partir de sources disponibles en ligne, et non des experts humains, et personne n'a été interrogé sur place. Le PDF démographique de l'Institut national de la statistique pour Agadez a renvoyé une erreur HTTP 500, et son bulletin trimestriel n'a pas pu être téléchargé. Les perspectives de FEWS NET d'octobre 2026 et le Cadre Harmonisé d'octobre–novembre 2026 n'étaient pas encore publiés. Les bulletins du SIMA de juillet à septembre 2026 ne figuraient pas sur le site miroir public. Aucune coordonnée issue d'une source n'a été trouvée pour le CHR, Assamaka ou le barrage de la Telwa ; aucune action n'est donc épinglée sur la carte, et toutes sont situées par zone. Il s'agissait de la première de deux notes produites au cours de cette session.

* Formulation suggérée : à vérifier auprès d'un agent de santé avant diffusion

Références · statut après vérification

Climate Impact Lab, données du El Niño Heat Mortality Tracker v261026 (téléchargées le 30 octobre 2026) ; tracker · confirmé

Méningite et diphtérie : WHO WER 101(38), campagne préventive Men5CV ; déclaration du gouvernement, campagne nationale ; OMS AFRO, épidémie de 2024 ; Veeken et al. 1998 ; Maïnassara et al. 2015 ; stratégies réactives, épidémies de 2015 ; Gavi, Men5CV ; INAM, gratuité des soins ; arriérés de la gratuité des soins · partiellement confirmé. mesvaccins.net, diphtérie 2026 ; méningite, 2009 ; WHO DON, 2015 · source secondaire ou non revérifiée

Désert et migrants : décès du 4 juin 2026 ; récit des survivants ; Alarme Phone Sahara, expulsions de 2025 ; coupes budgétaires de l'OIM ; Médecins du Monde, Agadez ; alerte Assamaka, 2023 ; OIM, admission et retour ; MSF, hébergement à Assamaka ; manifestations de 2022 ; ghettos d'Agadez · confirmé ou partiellement confirmé

Chaleur, électricité et radio : Hess et al. 2018 ; hypertension, Niamey ; ACASIS ; ECMWF SEWA ; Meade et al. 2024, ventilateurs ; Morris et al. 2021, ventilateurs ; JAMA, ventilateurs chez les personnes âgées ; WWA, chaleur d'avril 2024 au Sahel ; réseau électrique d'Agadez ; centrale hybride ; arrestations à Sahara FM ; PAM, alertes inondations en langues locales ; recette maison de SRO ; MSF, SRO · partiellement confirmé. décès liés à un réchaud, Buea ; Santé publique France, CO · non vérifié pour le Niger

Éleveurs et financement : note pastorale du CILSS, sept. 2026 ; FEWS NET Niger ; IFRC EAP2024NE04 ; cadre sécheresse du CERF ; activation inondations du CERF, janv. 2026 ; réassurance PAM/ARC ; Plan de Soutien 2022 ; leçons du déstockage, 2010 ; étude de cas LEGS ; réponse de la CRN en 2022 ; étude sur les arriérés de redevances minières ; départ du CICR ; suspensions d'ONG ; plan humanitaire du Niger ; taux de référence de la BCE · partiellement confirmé (CERF pour Agadez et ARC : non vérifié)

Alimentation et nutrition : bulletin SIMA n°349, juin 2026 ; FAO SMIAR (GIEWS) Niger ; Hoddinott et al., essai de Zinder ; déficit de carburant et interdiction d'exporter ; interdiction retirée ; reprise de l'approvisionnement à Niamey ; UNICEF, ATPE, T2 2026 ; SMART 2025 Niger ; Puett et al. 2013 · partiellement confirmé

Décompte des décès : Bamako, avril 2024 ; décompte des inhumations à Aden ; bilan de la chaleur en Afrique de l'Ouest, 2024 · confirmé (cause liée à la chaleur à Bamako non établie)

Inondations et historique : rupture du barrage, 2009 ; fonds de reconstruction, 2009 ; inondations de la vieille ville, sept. 2024 ; inondations de 2024, Grande Mosquée ; inondations de juillet 2025 ; étude d'assainissement pluvial du PIDUREM ; déficit pluviométrique 1969–1984 ; effondrement des troupeaux ; USAID, 2009–2010 ; FAO, 2010 ; population revendiquée (Comboni, 2026) · partiellement confirmé (reconstruction du barrage : non vérifiée)

Données d'exposition · Climate Impact Lab, 451,000 at Risk · Impact Map · Adaptation Inventory

Généré le 30 octobre 2026 pour Agadez, région d'Agadez. El Niño Ready est une initiative bénévole, sans lien avec la Climate Week NYC, The Climate Group ni l'Université Columbia.

* Formulation suggérée : à vérifier auprès d'un agent de santé avant diffusion